Capítulo 12
As bases teóricas e filosóficas das abordagens cognitivo-comportamentais

Eliane M. O. Falcone

"A dúvida não é um estado agradável, mas a certeza é absurda."
Voltaire

O avanço das ciências físicas e biológicas ocorrido no século XIX, cujas características marcantes foram a experimentação e os métodos objetivos de investigação, contribuiu fortemente para o surgimento das bases empíricas das abordagens cognitivo-comportamentais. Nessa época, a física se desenvolvia com o avanço de teorias que permitiam maior compreensão da matéria. A biologia, por sua vez, estava progredindo na descoberta da etiologia de determinadas doenças orgânicas e do tratamento destas. Juntando-se a esses fatos, os estudos de Darwin, que defendiam uma continuidade entre a espécie humana e a dos outros animais, incentivaram a investigação do comportamento animal para o entendimento do comportamento humano (Kazdin, 1983).

Os estudos com condicionamento se srcinaram primeiramente entre os investigadores russos, que começaram a aplicar os métodos objetivos da fisiologia aos problemas da psicologia. Dentre estes, o mais conhecido foi Ivan P. Pavlov (1849-1936), que realizou várias experiências com cães, a partir das quais deu srcem à teoria dos reflexos condicionados.

O mesmo modelo de condicionamento também foi realizado para eliciar respostas condicionadas de medo, onde uma luz vermelha, após alguns emparelhamentos com um estímulo incondicionado (choque elétrico), transformava-se em um estímulo condicionado, provocando respostas de medo nos animais. A partir desses achados, o paradigma de condicionamento clássico ou pavloviano passou a ter implicações para a compreensão de fenômenos psicopatológicos.

Os estudos dos investigadores russos passaram a influenciar os pesquisadores norte-americanos e, no final do século XIX, surgiu a psicologia experimental animal, que forneceu as bases para um outro modelo de condicionamento, conhecido como condicionamento operante, desenvolvido a partir de observações feitas por Edward L. Thorndike. Ao realizar uma série de experimentos com gatos, Thorndike encontrou que, após emitirem várias respostas, esses animais passavam a manifestar apenas uma: aquela que era seguida da possibilidade de acesso ao alimento. Esse fenômeno ficou conhecido como a "Lei do Efeito", segundo a qual, dentre as várias respostas emitidas em uma mesma situação, aquela que é seguida de satisfação do desejo do animal será a mais fortemente conectada com a situação (Baldwin e Baldwin, 1998).

Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) ampliou os estudos de Thorndike definindo o reforço como um estímulo que aumenta a probabilidade de ocorrência de uma resposta (Skinner, 1981). Diferentemente do modelo pavloviano, onde o reforço (estímulo incondicionado) está associado a um estímulo neutro, eliciando uma resposta condicionada, o reforço no condicionamento operante é contingente a uma resposta dada. Ele só ocorre após o comportamento se manifestar.

A psicologia experimental animal, surgida no final do século XIX, deu srcem ao behaviorismo, que representou uma revolução metodológica, na medida em que se propunha a estabelecer as bases científicas da psicologia.

Os behaviorismos metafísico, radical e metodológico

John Broadus Watson (1878-1958), ao fundar o behaviorismo, exerceu grande importância na clarificação e formalização da filosofia desta orientação. Embora seja reconhecido na literatura como representante do behaviorismo metodológico, sua rejeição ao conceito de "mente" fez com que o seu nome estivesse principalmente associado ao behaviorismo metafísico (Mahoney, 1974).

O behaviorismo metafísico negava a existência da "mente" e dos "estados mentais". Aceitar o conceito de "mente" implicaria aceitar uma teoria dualista, onde uma entidade espiritual (mente) influenciaria uma física (corpo) e vice-versa. Além disso, o mundo privado, por não ser diretamente observável, não poderia ser um foco de estudo. Assim, para não aderir ao dualismo mente-corpo, Watson adotou uma posição estrita de monismo

materialista onde todo comportamento humano, incluindo o pensamento, é o resultado de secreções glandulares e movimentos musculares.

O behaviorismo metafísico, por ser considerado ortodoxo até pelos behavioristas, não sobreviveu. Em vez deste, manteve-se o behaviorismo radical, representado por Skinner, que enfatizava a importância das relações empíricas entre os acontecimentos ambientais e o comportamento. Sua proposta era descrever essas relações e não gerar teorias e modelos de comportamento. Embora reconhecendo que os enunciados empíricos nunca estão totalmente livres de teoria, Skinner rejeitava aquelas teorias que expressavam os achados empíricos em termos não confirmados pelos mesmos métodos de observação utilizados para obtê-los. Assim, para se entender o comportamento não se deveria recorrer às ciências naturais tais como a fisiologia, nem a noções teóricas abstratas dentro da psicologia. A teoria, neste sentido, seria algo construído para compensar a inadequação dos dados, ou o controle imperfeito ou insuficiente sobre o objeto de estudo. Em outras palavras, a teoria representava para Skinner uma conseqüência da falta de compreensão dos fenômenos estudados. A rejeição de Skinner era dirigida principalmente às teorias que utilizavam variáveis intervenientes e construtos hipotéticos localizados no organismo. Assim, Skinner criticava os teóricos que propunham uma interpretação da aprendizagem em termos de E-O-R, em que O se referia a aspectos do organismo, em vez de componentes do estímulo e da resposta (E-R) bem fundamentados (Kazdin, 1983), tema a que voltaremos mais à frente.

O behaviorismo radical, representado por Skinner, manteve a posição de monismo materialista ao não aceitar o conceito de "mente", porém admitiu o estudo científico dos fenômenos privados. Assim, "[…] pensamentos não são substancialmente diferentes em virtude de sua natureza privada. Eles podem ter propriedades especiais porque são verbais, mas ainda são comportamentos" (Hayes, 1987: 330). Com base nesta proposição, o behaviorismo radical encontrou uma saída para estudar as reações humanas fazendo uma distinção entre público e privado, em vez de físico e mental, considerando este último como falso e dualista. Por rejeitar os processos mentais como recursos confiáveis de estudo na mediação do comportamento, o behaviorismo radical foi chamado de *não mediacional* (Mahoney, 1974).

O behaviorismo metodológico, ao contrário do behaviorismo radical, não estava preocupado comos impasses relacionados à aceitação da existência da mente. Michael Mahoney (1974) afirma que filósofos como Gilbert Ryle (1900-1976) já haviam convencido muitos cientistas comportamentais de que

o problema corpo-mente era apenas uma questão semântica. Desse modo, o behaviorismo metodológico estava mais preocupado com o método científico, que incluía a identificação de variáveis independentes e dependentes, além da inferência do que existe dentro do organismo (variáveis intervenientes). Os modelos de condicionamento clássico de Pavlov, além do condicionamento por contigüidade de Edwin R. Guthrie (1886-1959), do comportamentalismo propositivo de Edward C. Tolman (1896-1961) e da teoria hipotético-dedutiva do comportamento de Clark L. Hull (1884-1952), constituem exemplos que caracterizam o behaviorismo metodológico, uma vez que estes pressupõem um estado de consciência ou processamento cognitivo, mediando a aprendizagem.

Os investigadores russos já haviam reconhecido que o condicionamento clássico em seres humanos envolve muito mais do que o simples estabelecimento de vínculos estímulo-resposta. O modelo de condicionamento pavloviano, por exemplo, inclui a linguagem como um "segundo sistema de sinais", que fornece ao ser humano, de modo único, uma fonte infinita de estímulos condicionados e a capacidade de aprendizagem complexa. Mahoney (1974) cita vários experimentos realizados por esses investigadores demonstrando que as palavras podem não só estimular a ativação diretamente como também podem se transformar em elementos em cadeias de condicionamento de ordem mais elevada. O autor afirma:

> O papel crítico dos estímulos verbal e imaginário no comportamento humano é dramaticamente aumentado pelo fato dos seres humanos serem criaturas auto-estimuladoras. Logo após adquirir as habilidades de linguagem na infância, os seres humanos iniciam uma vida onde a fala coberta e encoberta dirigida a si mesmo é raramente interrompida. Os monólogos audíveis auto-instrucionais da criança são gradualmente substituídos por solilóquios inaudíveis que continuam a dirigir e influenciar o comportamento. Esta "internalização" gradual do comportamento da linguagem pode ser um desenvolvimento recente nas espécies (Mahoney, 1974: 40).

As especulações de Pavlov sobre a linguagem constituíram a base para o desenvolvimento do interesse dirigido ao estudo dos processos mentais complexos inerentes à aprendizagem humana. A insuficiência do modelo E-R obrigou os investigadores à necessidade de incluir variáveis intervenientes, fenômenos privados e processos conscientes em geral no estudo do comportamento. Tal necessidade, segundo Kazdin, "já havia sido evidente desde os primórdios do comportamentalismo e da teoria estímulo-resposta" (p. 253). Guthrie, que iniciou o seu trabalho dentro da tradição E-R,

admitiu que a especificação dos estímulos não era suficiente por si só para explicar o comportamento. Esse autor concluiu que o estudo dos processos de aprendizagem nos seres humanos necessitava explicar como o indivíduo percebia os estímulos e que significado tinha essa percepção. Tolman, por sua vez, propunha que os organismos desenvolvem cognições sobre diferentes estímulos e que a formação dessas cognições constituía a aprendizagem. O organismo aprendia estratégias de resposta e percebia relações gerais em seu ambiente. Assim, para que os animais aprendessem a solucionar um labirinto, desenvolviam mapas cognitivos dos estímulos ambientais e essas cognições eram responsáveis pelo comportamento (Kazdin, 1983).

A despeito das diferenças entre os behaviorismos radical e metodológico, a integração dos paradigmas de condicionamento pavloviano e skinneriano foi proposta por Hobart Mowrer (1928-1982), que descreveu um modelo de dois fatores para explicar o medo e o comportamento de evitação. A aquisição do medo aconteceria por meio do condicionamento clássico e, por ser o medo um estímulo aversivo, o animal aprende a reduzi-lo evitando os estímulos condicionados (reforçamento negativo).

Primeiras aplicações dos princípios de condicionamento

Condicionamento pavloviano

Dentre as primeiras tentativas de utilização dos princípios de condicionamento para os problemas de ansiedade, a mais famosa refere-se aos procedimentos de condicionamento realizados por Watson e Rayner, em 1920, com o "Pequeno Albert", um bebê de 11 meses. O objetivo desse experimento era demonstrar que as reações fóbicas eram aprendidas por meio de condicionamento. Albert era uma criança saudável que, ao ser colocada diante de um rato branco, não manifestou nenhuma reação de medo. Entretanto, após algumas sessões de condicionamento em que o aparecimento de um rato ficava associado a um barulho forte, Albert começou a manifestar medo do rato branco e de outros objetos semelhantes ao animal, tais como algodão, casaco de pele etc.

Posteriormente, Mary Cover Jones (1896-1987), em 1924, começou a aplicar os princípios de extinção para ajudar crianças com fobia a perder o medo. Dois métodos demonstraram ser eficazes. O primeiro foi realizado a partir da associação do objeto temido com uma resposta agradável (ex.,

comer uma barra de chocolate); o segundo consistiu na apresentação do estímulo fóbico na presença de outras crianças que não manifestavam nenhum temor.

Em 1935, Hobart Mowrer e Willie Mowrer desenvolveram um tratamento para a enurese noturna utilizando os princípios de condicionamento clássico em 30 crianças enuréticas com idades entre três e 13 anos. Partindo do princípio de que o controle da micção corresponde a uma reação aprendida e que as crianças com enurese noturna apresentam uma falha na resposta aos sinais (distensão da bexiga) que precedem a micção, os Mowrer aplicaram um método de tratamento baseado no condicionamento pavloviano, onde a distensão da bexiga corresponde ao estímulo condicionado ao controle do esfíncter e à inibição da micção. Um ruído forte servia como estímulo incondicionado e o despertar (acompanhado da contração do esfíncter) era a resposta incondicionada. Para a realização do experimento foi construído um colchão contendo em seu interior fios elétricos que se conectavam ao som de uma campainha. Quando a criança, dormindo, começava a urinar, esta molhava o colchão, ativando o circuito elétrico, que por sua vez acionava a campainha, provocando o despertar da criança. Após algumas repetições dessa experiência, a criança começava a acordar antes da micção e, posteriormente, passava a controlar o esfíncter sem precisar despertar. O procedimento conseguiu eliminar a enurese nos 30 participantes do estudo.

No início da década de 1950, na África do Sul, Joseph Wolpe (1915 - 1997) começou a realizar experimentos sobre "neurose experimental" em gatos, baseado nas pesquisas de Masserman (1943). Nesses experimentos, os gatos aprendiam a sentir medo do alimento, após alguns emparelhamentos com estímulos aversivos. Posteriormente, após aproximações sucessivas onde o gato era empurrado em direção à comida, na ausência da estimulação aversiva, a ansiedade se reduzia até a extinção. Wolpe concluiu que o medo condicionado e o ato de comer eram mutuamente antagônicos, ou seja, parecia haver uma inibição recíproca entre ambos. Wolpe testou essa hipótese alimentando os animais em locais cada vez mais próximos de onde eles haviam recebido o choque. Verificou então que o medo poderia ser reduzido mediante a apresentação concomitante de estímulos provocadores de ansiedade e estímulos que produziriam uma resposta antagônica e mais forte do que a ansiedade. Assim, os estímulos provocadores de ansiedade eram produzidos de forma gradual, dentro de uma hierarquia, começando por aqueles que provocassem ansiedade mais leve.

Para utilizar o seu trabalho em seres humanos, Wolpe criou a técnica de *dessensibilização sistemática* para tratar pacientes com fobia. Utilizou como resposta antagônica ao medo o relaxamento. Inicialmente, o paciente aprendia o exercício de relaxamento e, posteriormente, começava a enfrentar, passo a passo, as etapas da hierarquia de situações temidas, mantendo-se em relaxamento para inibir reciprocamente a reação de medo. As exposições ao estímulo temido poderiam ocorrer ao vivo ou pela imaginação. Os procedimentos detalhados da técnica de Wolpe podem ser encontrados em uma publicação traduzida para o português em 1981, com o título *Prática da terapia comportamental*.

A contribuição de Wolpe exerceu grande influência na práticada terapia comportamental. Entretanto, a base teórica da inibição recíproca deixou de exercer influência, uma vez que a exposição em situações na vida real foi vista como a forma mais eficaz de produzir reduções na ansiedade condicionada. Além disso, a exposição gradual e o uso de inibidores recíprocos, tais como o relaxamento, são desnecessários. Poroutro lado, atécnica da dessensibilização sistemática incentivou as pesquisas que levaram ao desenvolvimento atual das terapias baseadas na exposição (Hawton, Salkovskis, Kirk e Clark, 1997).

Outros investigadores que contribuíram para o desenvolvimento da terapia comportamental na África do Sul foram James G. Taylor e Leo J. Reyna, os quais exerceram influência sobre os estudos de Wolpe. Stanley J. Rachman e Arnold A. Lazarus trabalharam diretamente com Wolpe após o desenvolvimento da técnica de dessensibilização sistemática (Kazdin, 1983).

Na mesma época em que Wolpe realizava as suas pesquisas, Hans J. Eysenck (1916-1997) publicava na Inglaterra, em 1952, um trabalho com o título *The Effects of Psychotherapy: An Evaluation*. Nessa publicação, Eysenck avaliou a eficácia das terapias de orientação psicanalítica e a confiabilidade do diagnóstico psiquiátrico através da revisão da literatura psicoterápica. Eysenck não encontrou provas conclusivas de que a psicoterapia psicanalítica fosse mais efetiva do que a remissão espontânea (melhora produzida sem nenhum tratamento específico). Essa revisão tornou-se famosa e bastante polêmica, já que colocava em questão a eficácia da terapia psicanalítica. Os estudos de Eysenck despertaram maior preocupação com a verificação de eficácia psicoterápica em geral e com as possíveis limitações da terapia tradicional (Kazdin, 1983). Eysenck fundou, em 1963, a revista *Behaviour Research and Therapy*, a primeira dedicada à terapia do comportamento.

Outros autores que deram contribuições relevantes para a terapia comportamental na Inglaterra foram Shapiro, que chamou atenção para o

trabalho com o paciente individual, mais do que com as técnicas de mudança em geral; Meyer, que tratou do medo de espaços abertos e de lugares fechados utilizando métodos de aproximação sucessiva; e Yates, que desenvolveu técnicas de tratamento de tics (Kazdin, 1983).

Trabalhos com *terapia de aversão* foram também utilizados para tratar problemas de alcoolismo e desvios do comportamento sexual. Os estímulos, pensamentos ou comportamentos externos relacionados à resposta indesejada eram associados a um estímulo aversivo, tal como um choque elétrico. Esperava-se que esse tipo de condicionamento promovesse uma resposta de desagrado diante da bebida ou da estimulação sexual desviante. Entretanto, tais procedimentos foram desestimulados, tanto por razões éticas quanto pela sua ineficácia (Hawton *et al.*, 1997).

No início da década de 1960, os tratamentos comportamentais começaram a se expandir para uma variedade de problemas além da redução do medo, graças aos estudos de Shapiro que empregava uma metodologia de casos isolados, envolvendo repetição de medidas de variável clinicamente relevante, feita em intervalos regulares (série temporal).

Condicionamento operante

As aplicações dos procedimentos do condicionamento operante aos problemas clínicos tornaram-se conhecidas pelo nome de análise do comportamento aplicado e tiveram início no final dos anos 1950.

As primeiras técnicas concentraram-se na modificação do comportamento de pessoas com deficiência mental e de crianças deficientes. Com relação à modificação de comportamentos psicóticos tais como atos violentos, delírios e comportamento alimentar inadequado, assim como hábitos de higiene, Ayllon utilizou cigarros e elogios como reforçadores de comportamentos sadios e supressão da atenção ao paciente como extinção de comportamentos inadequados.

Em 1961, Ayllon e Azrin criaram um esquema de reforçamento denominado *sistema de fichas*, as quais funcionavam como reforçadores que poderiam ser trocados por uma série de privilégios à escolha do paciente. Esse trabalho demonstrou a eficácia da intervenção psicológica em pacientes psicóticos (especialmente aqueles com esquizofrenia crônica), que antes não eram considerados passíveis de mudança. Posteriormente, foi ressaltada a importância do reforço social e do *feedback* como fatores mais importantes

nesses programas. O uso de reforçadores sociais estruturados (elogio e atenção do terapeuta) passou a ser mais amplamente adotado, assim como uma maior valorização das interações sociais na ajuda a pacientes com esquizofrenia (Hawton *et al.*, 1997).

Vários estudos citados por Kazdin (1983) realizados em crianças deficientes e autistas foram implementados com êxito na década de 1960, na Rainier School e na Universidade de Washington.

Os princípios do condicionamento operante também foram aplicados na área da educação, através do ensino programado, onde o material acadêmico era apresentado de forma individual para cada estudante, proporcionando reforço imediato às suas respostas. No início dos anos 1960, vários editores começaram a publicar uma grande quantidade de material programado para uso em aula e uma elevada percentagem de escolas nos Estados Unidos começou a utilizar material educativo programado.

Surgimento e evolução das abordagens cognitivo-comportamentais

Ao final dos anos 1960, iniciou-se um movimento de insatisfação com os modelos estritamente comportamentais (E-R) ou não mediacionais de abordagem ao comportamento humano. Embora – como foi mencionado no início deste capítulo – muitos modelos de condicionamento tenham apontado a existência de processos cognitivos como mediadores de estímulos, o auge desse fenômeno ocorreu no final dos anos 1960 e início dos 1970 (Dobson e Scherrer, 2004).

Albert Bandura (1925-) foi um dos críticos mais poderosos do modelo operante de condicionamento e suas contribuições neste sentido serviram de base para o movimento mediacional. Para Bandura (1969), um dos problemas da aprendizagem pelas conseqüências refere-se ao fato de que o indivíduo deve se comportar *antes* de aprender. O modelo operante pressupõe que o indivíduo somente aprenderá após a ocorrência de reforçadores que se sucedem a sua resposta. Assim, se toda aprendizagem ocorresse através do condicionamento operante, poucas pessoas sobreviveriam. Como seria, por exemplo, aprender a nadar ou a pilotar um avião pelo modelo operante? Bandura propôs uma teoria da aprendizagem sem tentativa, conhecida como *modelação*, que é altamente freqüente entre os seres humanos e que se dá pela simples observação, sem a necessária reprodução do comportamento. Uma parte considerável da aprendizagem social é desenvolvida pela exposição a

modelos da vida real que desempenham, intencionalmente ou não, padrões de comportamento que podem ser imitados pelos outros. Depois que a pessoa desenvolve um repertório verbal adequado, os modelos podem ser verbais. Assim, personagens de filmes, de propagandas, figuras históricas etc. podem funcionar como modelos poderosos. Os pais, professores e irmãos mais velhos costumam ser modelos para as crianças. Nos grupos sociais, estamos constantemente imitando atitudes de algumas pessoas e, ao mesmo tempo, somos modelo para outras.

A modelação implica processos cognitivos importantes que envolvem atenção, julgamento sobre o modelo e as conseqüências do comportamento deste etc. indicando que a mediação cognitiva influencia o comportamento. Para Bandura, a conseqüência da resposta não exerce uma influência puramente instrumental sobre o comportamento. Ela também é conceituada como um processo cognitivo. A partir da observação de suas próprias ações, o indivíduo vai discernir respostas apropriadas e inapropriadas e vai se conduzir de acordo com esse julgamento. A concepção de resposta apropriada é construída pelo próprio indivíduo, a partir da observação de seu comportamento. Em outras palavras, o reforço aumenta a probabilidade de ocorrência de uma resposta pela sua função preditiva, e não porque ele esteja automaticamente conectado à resposta. Assim, a motivação também tem base cognitiva e é influenciada pela previsão das consequências futuras.

Dentre os conceitos mais importantes da teoria de aprendizagem social de Bandura, que contraria a explicação operante sobre o poder da contingência, encontra-se o de *auto-eficácia*, que se refere à crença que uma pessoa tem de que será capaz de realizar um determinado comportamento. A força da convicção da pessoa sobre a própria eficácia influencia no quanto ela vai tentar enfrentar as situações dadas. Isso irá determinar tanto a iniciação quanto a persistência do comportamento. As contribuições de Bandura sobre *auto-eficácia* se estendem hoje a uma variedade de pesquisas, tanto na psicologia social, em estudos sobre idosos e sobre evasão acadêmica, como na clínica e na saúde, no entendimento das dependências químicas, na depressão e em outros transtornos psicológicos.

Em 1974, Michael Mahoney publicou um livro intitulado *Cognition and Behavior Modification*, em que defendeu a cognição como mediadora do comportamento. Um dos motivos da rejeição ao estudo dos fenômenos cognitivos por parte dos behavioristas radicais devia-se ao fato de que este era baseado em inferências, significando que o que é inferido não poderia se aplicar ao estudo do comportamento. Mahoney sustentou que o que caracteriza

um conhecimento científico não é a sua ausência de inferências, mas sim a sua capacidade preditiva:

> A questão básica nas explicações mediacionais *versus* não-mediacionais do comportamento não é se as inferências são justificáveis, mas sim *quais* inferências são legítimas e úteis. Como foi referido antes, a aceitação de uma hipótese ou teoria é determinada por sua adequação e força preditiva, e não por sua parcimônia ou falta de inferências. Muitos behavioristas, é claro, presumem que há uma forte correlação positiva entre estas características – ou seja, que asexplicações não inferenciais e parcimoniosas do comportamento são mais capazes de precisão preditiva e amplitude explicativa. Esta é, de fato, a base da interpretação errônea da postura de Skinner acerca da mediação e da inferência (Mahoney, 1974: 26).

Outros autores também desafiaram os princípios estritamente comportamentais. Dobson e Scherrer (2004) citamo trabalho de Vygotsky realizado em 1962 com crianças que estavam aprendendo regras gramaticais com sucesso, independentemente da habilidade de pais e educadores para usarem reforço discriminativamente. Esses autores citam também o trabalho de Mischel, Ebbesen e Zeiss (1972) sobre retardo na gratificação.

Além da insatisfação com os modelos E-R, outros fatores históricos e contextuais contribuíram para o desenvolvimento das abordagens cognitivo-comportamentais. O primeiro desses fatores refere-se à rejeição dos modelos psicodinâmicos e ao questionamento de sua eficácia.

Rachman e Wilson (1980, citados por Dobson e Block, 1988) afirmaram não haver indícios aceitáveis que sustentassem a visão da psicanálise como uma abordagem de tratamento eficaz. Dobson e Scherrer (2004) mencionam trabalhos de Albert Ellis (1973) e Aaron Beck (1967) em que ambos, embora vindos de uma tradição psicodinâmica, revelaram divergências filosóficas para com diversos princípios básicos desse modelo. No prefácio de uma publicação traduzida para o português intitulada *Terapia cognitiva da depressão*, Beck (Beck, Rush, Shaw e Emery,1982) relata que seus questionamentos ao modelo psicanalítico tiveram início em 1956, quando este tentava validar a formulação psicanalítica da depressão. Ao verificar que a hipótese da raiva retrofletida não se confirmara em seus estudos, levando-o a outras descobertas (como, por exemplo, a tríade negativista da depressão), Beck procurou embasamento nas teorias cognitivas para explicar a depressão.

Outro fator histórico-contextual que culminou no desenvolvimento das abordagens cognitivo-comportamentais refere-se a uma atenção crescente dada aos aspectos cognitivos do funcionamento humano na psicologia geral, aliados ao desenvolvimento, pesquisa e estabelecimento

de diversos conceitos mediacionais na psicologia experimental. Os modelos de processamento de informação (cf. capítulo 13) passaram a ser cada vez mais aplicados em construtos clínicos, tal como se pode ver nas publicações sobre mediação cognitiva da ansiedade referidas em uma revisão de estudos feita por Dobson e Scherrer (2004). Assim, tanto a psicologia cognitiva em geral quanto a psicologia cognitiva aplicada acumularam evidências que desafiavam os modelos estritamente comportamentais a explicar esses dados pela incorporação de fenômenos cognitivos. Todas essas evidências levaram os teóricos comportamentais a redefinirem os seus limites e a incorporarem fenômenos cognitivos dentro dos modelos de mecanismo comportamental (Dobson e Block, 1988).

Finalmente, a crescente identificação de diversos terapeutas e teóricos como de orientação cognitivo-comportamental, aliada às pesquisas de resultados, na maioria positivos, das intervenções clínicas cognitivo-comportamentais, constituiu mais um fator contextual de desenvolvimento dessa abordagem. Dobson e Scherrer (2004: 45) afirmam que a autodenominação de muitos profissionais como cognitivo-comportamentais "resultou em um *zeitgeist* que chamava cada vez mais atenção para o campo crescente da TCC" (terapia cognitivo-comportamental). Todo esse movimento gerou a criação da revista científica *Cognitive Therapy and Research*, em 1977, que abriu mais espaço para a divulgação desse enfoque.

Princípios das abordagens cognitivo-comportamentais: o foco na cognição, na emoção e implicações para o tratamento

As abordagens cognitivo-comportamentais compartilham diversas características fundamentais, mas também manifestam considerável diversidade de princípios e de procedimentos. Dobson e Scherrer (2004) explicam essa diversidade pelas diferentes srcens teóricas de seus representantes. Eles citam Beck e Ellis, por exemplo, como vindos de uma tradição psicanalítica, enquanto apontam Marvin R. Goldfried, Donald Meichenbaum e Mahoney como treinados na abordagem comportamental.

A premissa básica das abordagens cognitivo-comportamentais refere-se à existência de um processo interno e oculto de cognição, sendo o comportamento mediado por eventos cognitivos. Um mesmo evento pode ser considerado como agradável para uma pessoa, gerando um comportamento

de se manter na situação, ou ameaçador para outra, provocando nesta intensa ansiedade e retraimento. Assim, não é o evento em si que gera emoções e comportamentos, mas sim a nossa interpretação do mesmo.

Uma das diferenças existentes entre os diversos modelos teóricos cognitivo-comportamentais está no papel das cognições e das emoções. Para alguns autores, tais como Beck e Ellis, existe uma ênfase na explicação das cognições como mediadoras do comportamento e como influenciadoras das emoções, embora estas últimas também possam influenciar as cognições. Por outro lado, autores de enfoque cognitivo-construtivista defendem o papel das emoções como preponderantes na influência do comportamento.

Embora existam várias formas de abordagens cognitivo-comportamentais, a terapia racional emotivo-comportamental de Ellis e a terapia cognitiva de Beck são consideradas como as mais conhecidas e influentes.

O modelo ABC de Ellis, por exemplo, propõe que os sintomas ou conseqüências neuróticas (C – *consequences*) são determinados pelos sistemas de crença do indivíduo (B – *believes*) com relação às experiências ou fatos ativadores (A – *activatics)*. Os indivíduos tendem a preservar vigorosamente os seus padrões de pensamentos irracionais, formados a partir de tendências inatas e adquiridas. A intervenção baseada nesse modelo teórico visa identificar e contestar as crenças irracionais através de um automonitoramento, em que a pessoa contesta o seu próprio sistema de crenças para manter um estado de saúde emocional. Técnicas cognitivas, de imagem, de relaxamento e desenvolvimento de habilidades são empregadas para atingir esse objetivo (Rangé, 2001). Estudos avaliando a eficácia da terapia racional emotivo-comportamental estão surgindo mais recentemente (Dobson e Scherrer, 2004).

O modelo cognitivo de Beck enfatiza que os pensamentos influenciam as nossas emoções e comportamentos. Os pensamentos ocorrem em três diferentes níveis. Em um nível mais superficial, encontram-se os pensamentos automáticos, que correspondem às avaliações de eventos específicos (por exemplo, "acho que vou me ferrar nessa prova"). Embora não estejamos conscientes desses pensamentos, eles podem ser facilmente acessíveis mediante treinamento. Em um segundo nível estão as suposições e regras, que são mais globais, menos diretamente associadas a um evento específico e menos acessíveis à nossa consciência (exemplo, "para ser competente, eu não posso falhar", ou "se cometer um erro, significa que sou incapaz"). Finalmente, as crenças centrais constituem o nível mais global da cognição. São construídas no início do desenvolvimento e fortalecidas com as experiências da vida.

As crenças centrais, as suposições e regras, e os pensamentos automáticos estão interligados no processamento cognitivo dos transtornos psicológicos. Se um indivíduo possui uma crença central (por ex., "sou incompetente"), ele criará suposições para enfrentar essa crença (por ex., "se eu der o melhor de mim e me esforçar ao máximo, serei aceito pelos outros"; "se eu demonstrar ansiedade, significa que sou incapaz"). Tais crenças predispõem esse indivíduo a desenvolver estratégias (por ex., estabelecer padrões irrealistas de desempenho, monitorar exageradamente as próprias reações pessoais) que provavelmente o tornarão predisposto a confirmar a crença central, através de uma forma tendenciosa de interpretar os acontecimentos. Ao estabelecer padrões irrealistas de desempenho, por exemplo, ele tenderá a supervalorizar as próprias falhas, a ignorar os seus sucessos e a prestar atenção excessiva em suas manifestações de ansiedade, levando à confirmação de que é incompetente (para leitura mais detalhada do assunto, ver Falcone, 2001; J. Beck, 1997).

O modelo de Beck tem sido aperfeiçoado para dar conta de um melhor entendimento de transtornos psicológicos mais graves, tais como os transtornos de personalidade, para os quais tem sido sugerido o papel dos esquemas, definidos como "estruturas internas relativamente duradouras de características genéricas ou prototípicas armazenadas de estímulos, idéias ou experiências que são utilizados para organizar novas informações de um modo significativo, deste modo determinando como os fenômenos são percebidos e conceitualizados" (Dobson e Scherrer, 2004: 47). Os esquemas são desenvolvidos no início da infância e atuam como "filtros" pelos quais as informações são processadas. Os esquemas adaptativos possibilitam avaliações flexíveis, realistas, enquanto os desadaptativos são rígidos e levam à distorção da realidade.

O objetivo da terapia cognitiva é ajudar o cliente a desenvolver habilidades para identificar as suas distorções cognitivas e explorar novas formas de entender as suas experiências. A estratégia da abordagem é colaborativa, de modo a ajudar o indivíduo a construir os próprios recursos para testar a validade de suas interpretações.

Dattilio e Padesky (1995) realizaram uma revisão de estudos para avaliar os resultados da terapia cognitiva e constataram ser esta tão eficaz quanto os medicamentos para o alívio da depressão maior, além de apresentar uma taxa inferior de recaídas em comparação com medicamentos. Outra revisão feita por Beck (1997) revelou a eficácia da terapia cognitiva no tratamento de transtornos da ansiedade, transtornos alimentares, abuso de substâncias, problemas conjugais e depressão de pacientes internados. Atualmente,

resultados positivos da terapia cognitiva têm sido encontrados no tratamento do transtorno bipolar (Juruena, 2004) e da esquizofrenia (Barretto e Elkis, 2004).

Além da terapia racional emotivo-comportamental de Ellis e da terapia cognitiva de Beck, outras abordagens cognitivo-comportamentais surgiram com o passar dos anos, embora não tenham atingido uma posição tão influente. Entre estas se incluem: a reestruturação sistemática de Goldfried (1974); o treinamento de auto-instrução e de inoculação de estresse desenvolvido por Donald Meichenbaum nos anos 1970; a teoria de resolução de problemas de D'Zurilla e Goldfried, na década de 1970; e a terapia de autocontrole, construída por Fuchs e Rehm, em 1977 (citados por Dobson e Scherrer, 2004).

Desenvolvimentos mais recentes da abordagem cognitivo-comportamental referem-se às terapias estruturais e construtivistas. Guidano e Liotti criaram na década de 1980 uma abordagem estrutural da psicoterapia, em razão do potencial explicativo limitado da teoria da aprendizagem. Para esses autores, a organização cognitiva de um indivíduo, incluindo teorias causais, pressupostos básicos e regras tácitas de inferência que determinam o conteúdo dos pensamentos, desempenha um papel causal nos comportamentos problemáticos. Para mudar essas estruturas cognitivas disfuncionais, a terapia começa com a identificação e modificação de estruturas cognitivas superficiais e depois, das mais profundas (teorias causais implícitas mantidas pelo paciente) (Dobson e Scherrer, 2004).

Embora existam aspectos comuns entre a terapia estrutural de Guidano e Liotti e as outras formas de abordagem cognitivo-comportamental quanto à identificação e modificação de estruturas cognitivas, estas últimas são consideradas racionais, uma vez que o seu pressuposto filosófico é o de que existe um mundo externo que pode ser percebido de forma correta ou incorreta. Por outro lado, Guidano mostrou-se mais preocupado com o "valor de validade" das estruturas cognitivas do que com o seu "valor de verdade" (Dobson e Scherrer, 2004).

Para os terapeutas de enfoque construtivista, que têm atualmente Mahoney como um dos principais defensores, a terapia consiste em enfatizar o processo de dar significado à experiência, em oposição ao conteúdo do que está sendo pensado. Assim, as estratégias focalizam-se em exercícios facilitadores que enfatizam o processo do pensamento e a produção de significado, em oposição aos exercícios corretivos em torno do conteúdo do pensamento (Dobson e Scherrer, 2004).

Enquanto alguns autores (por ex., Neimeyer e Raskin, 2001) questionam a compatibilidade teórica entre as terapias construtivistas e cognitivo-comportamentais, outros defensores das terapias cognitivo-comportamentais adotaram, em graus variados, tratamentos com base em princípios construtivistas (por ex., Mahoney, 1991; Meichenbaum, 1994; Young, 1994, citados por Dobson e Scherrer, 2004). Assim, as questões sobre a compatibilidade teórica entre os enfoques cognitivo, construtivista e pós-racionalista ainda não são conclusivas.

Popularidade e abrangência das abordagens cognitivo-comportamentais

Em uma pesquisa realizada por Robins, Gosling e Craik (1999), a abordagem cognitivo-comportamental é apontada como a que mais obteve popularidade nos últimos 20 anos. Embora esse estudo não faça menção aos locais onde essa popularidade se manifesta, sua metodologia baseou-se em uma meta-análise de publicações existentes em um determinado período sobre as diversas abordagens teóricas, o que permite perceber o avanço crescente das abordagens cognitivo-comportamentais em todo o mundo. Outro estudo realizado por Buela-Casal, Alvarez-Castro e Sierra (1993), para avaliar as preferências dos psicólogos na Espanha, concluiu que os psicólogos espanhóis manifestam uma clara preferência pela abordagem cognitivo-comportamental.

Parece existir um consenso na literatura sobre a popularidade da abordagem cognitivo-comportamental na psicologia clínica e na psicologia da saúde, nos Estados Unidos e na Europa. Paul M. Salkovskis (2005), em seu livro recentemente traduzido para o português com o título: *Fronteiras da terapia cognitiva* propõe que "[…] a terapia cognitiva se tornou a abordagem psicoterápica mais importante e a melhor validada entre as demais. É o tratamento psicológico de escolha para uma ampla variedade de problemas psicológicos" (p. 15). Em entrevista concedida a uma revista argentina (1999), esse autor afirma:

> Um avanço na Inglaterra consistiu em que o Colégio de Psiquiatras exige que os psiquiatras tratem vários casos com terapia cognitiva em seu treinamento, de tal maneira que eles não podem converter-se em psiquiatras sem haver recebido supervisão em terapia cognitiva (p. 187).

Para Dobson e Scherrer (2004), as abordagens cognitivo-comportamentais "têm aumentado de escopo e popularidade, adquirindo sua atual condição de 'paradigmas dominantes' na área da psicologia clínica" (p. 42). Em publicação

recente traduzida para o português com o título *Ciência psicológica: mente, cérebro e comportamento* (2005), os autores Michael S. Gazzaniga (neurocientista) e Todd F. Heatherton (psicólogo social e da personalidade) apontam a terapia cognitivo-comportamental como a mais eficaz no tratamento dos transtornos da ansiedade, do humor e da personalidade.

No Brasil, a popularidade das abordagens cognitivo-comportamentais está apenas começando e pode ser identificada principalmente pela crescente publicação de livros organizados por autores brasileiros nos últimos cinco anos. Alguns desses autores são de São Paulo (Abreu e Rosa, 2003; Lipp, 2004; Silvares, 2000), Rio de Janeiro (Range, 2001) e Rio Grande do Sul (Caminha, 2005; Caminha, Wainer, Oliveira e Piccoloto, 2003; Knapp, 2004). Além dos livros nacionais, a quantidade de publicações traduzidas para o português tem aumentado consideravelmente. Uma variedade de publicações em periódicos nacionais pode ser também encontrada.

A popularidade das abordagens cognitivo-comportamentais tem aumentado em parte graças à fundação de associações itinerantes que organizam congressos anuais (Associação Brasileira de Psicoterapia e Medicina Comportamental – ABPMC, fundada no Rio de Janeiro em 1991) e a cada dois anos (Sociedade Brasileira de Terapias Cognitivas – SBTC, fundada no Rio Grande do Sul em 1997). A primeira publica a *Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva*, desde 1999. A segunda publica a *Revista Brasileira de Terapias Cognitivas*, fundada em 2005. Associações regionais também têm surgido, como a Associação de Terapias Cognitivas do Estado do Rio de Janeiro (ATC-RIO), que organiza, juntamente com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, um evento anual (Mostra de Terapia Cognitivo-Comportamental).

Os profissionais brasileiros de orientação cognitivo-comportamental têm se dedicado a intervenções em consultórios, além de pesquisa, ensino, orientação e supervisão clínica. A prática clínica institucional tem sido realizada por um grupo do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, em um ambulatório de ansiedade (ANBAM), onde psicólogos e psiquiatras exercem atividades de ensino, pesquisa e intervenção cognitivo-comportamental.

No campo da psicologia da saúde, tem se destacado o trabalho de um grupo de psicólogos de São José do Rio Preto, que desenvolveram o Serviço de Psicologia do Hospital de Base da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), iniciado em 1981 com a contratação de uma psicóloga para atuar na enfermaria de pediatria e contando atualmente com 40 psicólogos (docentes, contratados e aprimorandos) que desenvolvem atividades de extensão de serviços à comunidade, ensino e pesquisa em psicologia da saúde. A história

e estrutura desse serviço está publicada em detalhes na revista *Psicologia USP* (Miyazaky, Domingos, Valério, Santos e da Rosa, 2002).

Conclusões

Embora compartilhando de pressupostos básicos, as abordagens cognitivo-comportamentais abrangem uma variedade de mais de 20 modelos (Mahoney e Lydoon, 1988, citados em Knapp, 2004). Além disso, mudanças filosóficas, teóricas e práticas importantes têm ocorrido na sua trajetória. Assim, relatar a sua história e seus princípios teóricos e filosóficos em um capítulo não constitui uma tarefa fácil.

Contrariamente às afirmações de que as abordagens cognitivo-comportamentais são de srcem estadunidense, pode-se verificar, na revisão deste capítulo, que os investigadores russos foram tão importantes (ou mais) para o behaviorismo (pelo menos para o behaviorismo metodológico) do que os próprios americanos, e que os estudos de Pavlov servem de base até hoje para os estudos da neuropsicologia, através da relação entre áreas do cérebro e o comportamento (Caminha, 2003).

A preocupação com a eficácia dos procedimentos de intervenção e com a revisão de princípios teóricos faz com que as abordagens cognitivo-comportamentais sejam alvo de reformulações através do tempo, o que provavelmente constitui a sua característica mais marcante.

Indicação bibliográfica

O livro organizado por Knapp – *Terapia cognitivo-comportamental na prática psiquiátrica.* Porto Alegre: Artmed. – é uma boa apresentação do tema.

Referências

Abreu, C. N. e Roso, M. (orgs.) (2003) *Psicoterapias cognitiva e construtivista. Novas fronteiras na prática clínica.* Porto Alegre: Artmed.

Baldwin, J. D. e Baldwin, J. I. (1998) *Behavior Principles in Everyday Life.* 3rd ed. New Jersey: Prentice-Hall.

Bandura, A. (1969) *Modificação do comportamento.* Rio de Janeiro: Editora Interamericana.

Barretto, E. M. P. e Elkis, H. (2004) Esquizofrenia. In: P. Knapp (org.) *Terapia cognitivo-comportamental na prática psiquiátrica*. Porto Alegre: Artmed.

Beck, A. T.; Rush, A. J.; Shaw, B. F. e Emery, G. (1982) *Terapia cognitiva da depressão* Rio de Janeiro: Zahar.

Beck, J. S. (1997) *Terapia cognitiva. Teoria e prática* Porto Alegre: Artes Médicas.

Buela-Casal, G.; Álvares-Castro, S.; Sierra, J. C. (1993) Perfil de los psicólogos de la ultima promocion de las universidades españolas. *Psicología Conductual*, 1, 181-206.

Caminha, R. M. (org.) (2005) *Transtornos do estresse pós-traumática. Da neurobiologia à terapia cognitiva*. São Paulo: Casa do Psicólogo.

Caminha, R. M.; Wainer, R.; Oliveira, M. e Piccoloto, N. M. (orgs.) (2003) *Psicoterapias cognitivo-comportamentais. Teoria e prática* São Paulo: Casa do Psicólogo.

Dattilio, F. M. e Padeski, C. A. (1995) *Terapia cognitiva com casais* Porto Alegre: Artes Médicas.

Dobson, K. S. e Block, L. (1988) Historical and philosophical bases of the cognitive-behavioral therapies. In: K. S.Dobson (ed.) *Handbook of Cognitive-behavioural Therapies*. Nova York: Guilford.

Dobson, K. S. e Scherrer, M. C. (2004) História e futuro das terapias cognitivo-comportamentais. In: P. Knapp (org.) *Terapia cognitivo-comportamental na prática psiquiátrica* Porto Alegre: Artmed.

Falcone, E. (2001) Psicoterapia cognitiva. In: B. Range. (org) *Psicoterapias cognitivo-comportamentais. Um diálogo com a psiquiatria*. Porto Alegre: Artmed.

Gazzaniga, M. S. e Heatherton, T. F. (2005) *Ciência psicológica. Mente, cérebro e comportamento*. Porto Alegre: Artmed.

Hawton, K.; Salkovskis, P. M.; Kirk, J. e Clark, D. M. (1997) Desenvolvimento e princípios das abordagens cognitivo-comportamentais. In: K. Hawton, P. M. Salkovskis, J. Kirk, e D. M. Clark (orgs.) *Terapia cognitivo-comportamental para problemas psiquiátricos. Um guia prático* São Paulo: Martins Fontes.

Hayes, S. C. (1987) *A Contextual Approach to Therapeutic Change*. In: N. S. Jacobson (ed.) Psychotherapists in Clinical Practice. Nova York: Guilford.

Juruena, M. F. (2005) Transtorno afetivo bipolar. In: P. Knapp (org.) *Terapia cognitivo-comportamental na prática psiquiátrica*. Porto Alegre: Artmed.

Kazdin, A. E. (1983) *Historia de la modificación de conducta*. Bilbao: Desclée de Brouwer.

Knapp, P. (org.) (2004) *Terapia cognitivo-comportamental na prática psiquiátrica* . Porto Alegre: Artmed.

Lipp, M. (org.) (2004) *O stress no Brasil. Pesquisas avançadas*. São Paulo: Papirus.

Mahoney, M. J. (1974) *Cognition and Behavior Modification* . Cambridge: Ballinger Publishing Company.

Miyazaki, M. C. O. S.; Domingos, N. A. M.; Valério, N. I.; Santos, A. R. R.; Rosa, L. T. B. (2002) Psicologia da saúde: Extensão de serviços à comunidade, ensino e pesquisa. *Psicologia USP* 13, 29-53.

Pavlov, I. (1972) *Reflexos condicionados e inibições*. 5ª ed. Rio de Janeiro: Zahar.

Range, B. (org.) (2001) *Psicoterapias cognitivo-comportamentais. Um diálogo com a psiquiatria*. Porto Alegre: Artmed.

Robins, R. W.; Gosling, S. D.; Craik, K. H. (1999) An Empirical Analysis of Trends in Psychology. *American Psychologist (APA)*, 54, 117-128.

Salkovskis, P. (1999) Entrevista de clinica psicologica con Paul Salkivskis. *Revista Argentina de Clínica Psicológica*, 8, 183-187.

___(2005) Prefácio. In: P. M. Salkovskis (org.) *Fronteiras da terapia cognitiva*. São Paulo: Casa do Psicólogo.

Silvares, E. F. M. (org.)*Estudos de caso em psicologia clínica comportamental infantil*, vols. I e II. São Paulo: Papirus.

Skinner, B. F. (1981) *Ciência e comportamento humano*. São Paulo: Martins Fontes.

Wolpe, J. (1981) *Prática da terapia comportamental*. São Paulo: Brasiliense.

Capítulo 13
A psicologia no contexto das ciências cognitivas

Virgínia Kastrup

Como temos visto ao longo deste livro, a história da psicologia é marcada por cruzamentos e interfaces com disciplinas diversas, como a filosofia, a física, a fisiologia, a teoria da evolução e as ciências sociais. Na segunda metade do século XX, assistimos a uma ampliação significativa da rede de saberes que participa da transformação da psicologia ao longo do tempo. A apresentação e análise de um domínio recente como o das ciências cognitivas será ocasião de compreender que a história de uma disciplina não se limita à investigação de seu passado, mas inclui a história do presente, onde o processo de transformação ainda não se sedimentou em extratos históricos bem estabelecidos, mas encontra-se ainda vivo e em pleno processo de invenção. Fazer o mapeamento do campo das ciências cognitivas na atualidade é, portanto, aceitar o desafio de abordar um movimento que, fazendo parte de nosso contemporâneo, vem produzindo modificações importantes no saber psicológico. O quadro que apresentamos é, portanto, marcado por uma seleção que incluiu escolhas e, certamente, algumas omissões que não poderiam deixar de acontecer, tendo em vista a extensão do campo. Nosso critério foi trazer a cena movimentos, abordagens, autores, problemas e discussões que, por seu caráter inovador e polêmico, forçaram a psicologia a repensar e reinventar o conceito de cognição.

Cabe ressaltar que, por seus objetivos e pela natureza das questões que se situam no coração dos debates, o campo das ciências cognitivas distingue-se de forma bem nítida do domínio do desenvolvimento cognitivo. Como veremos adiante, temas como a transformação temporal da cognição e os estágios da inteligência da infância à idade adulta dão lugar a questões de natureza epistemológica, discutidas num contexto interdisciplinar e que incidem, em seus primórdios, sobre a possibilidade de simulação da mente através dos modelos computacionais. O diálogo entre as ciências cognitivas e a